

Douleurs en urinant

Anamnèse

1. Caractérisation de la douleur
 - a. Qualité
 - b. Intensité
 - c. Irradiation
 - d. Facteurs aggravants et soulageant
 - e. Symptômes associés
 - f. Chronologie de la douleur
 - i. Début
 - ii. Circonstance de survenue
 - iii. Évolution
2. Anamnèse urologique
 - a. Fréquence mictionnelle
 - b. Quantité d'urine
 - c. Couleur des urines
 - d. Présence de sang
 - e. Impériosité**
 - f. Nycturie**
 - g. Latence mictionnelle**
 - h. Jet saccadé**
 - i. Sensation de mal vidange vésicale**
3. Anamnèse génitale
 - a. Pertes vaginales**
 - b. Prurit vaginal
 - c. Date des dernières règles
4. **Anamnèse sexuelle** (il est fréquent que ce genre de symptôme soit associé à la sexualité, je me permets donc de vous demander...)
 - a. Pratiques (types)
 - b. Partenaires (genre, nombre)
 - c. Type de protection utilisée durant les rapports
 - i. !!! Prep protège du VIH mais pas des autres IST
 - d. Antécédent IST
 - e. Moyens contraceptifs utilisés
5. Anamnèse générale
 - a. Fièvre
 - b. Transpiration
 - c. Perte de poids involontaire
6. Antécédent personnel
 - a. Maladie comorbidités
 - b. Interventions ou hospitalisations
 - c. Allergies
 - d. Médicaments
7. Antécédents familiaux

Examen clinique

1. Installation
 - a. Bras et jambes décroisées
 - b. Tête légèrement surélevée
 - c. Abdomen entièrement visible
 - d. Se place à droite du patient
2. Inspection
 - a. Visage : malaise, douleur
 - b. Peau : cicatrices, veines dilatées, lésions cutanées, vergetures, ictères
 - c. Omphalique
 - d. Allure de l'abdomen : plat, arrondi, symétrie, voussure
 - e. Mouvements : respiratoire, péristaltique, pulsatiles
3. Auscultation (**avant palpation**)
 - a. 4 quadrants (fréquence gargouilles : 5-34/min)
 - b. Aorte
 - c. A. iliaque
4. Percussion
 - a. 4 quadrants
 - b. Délimite la taille du foie
5. Palpation (+ check visage patient, si résistance, le faire en expiration et en respirant par la bouche ouverte, mâchoire tombante)
 - a. 4 quadrants
 - i. Superficielle (1 main)
 - ii. Profonde (2 mains)
 - iii. Détente et défense
 - b. Palpation du foie
 - c. Palpation de la rate
 - d. Palpation des reins
 - e. Palpation vessie
 - f. Aorte (anévrisme)
 - g. Orifice herniaire
6. Tests spécifiques
 - a. Mc Burney
 - b. Signes du psoas
 - c. Signe de Murphy
7. Percussion des reins
8. **EVOQUER UN TOUCHER RECTAL + PALPATION AIRES INGUINALES**

DD

- **Infection urinaire basse** (cystite : pollakiurie, dysurie, femme)
- **Pylénonéphrite** (percussion rein douloureux)
- **Trouble mictionnel lié à l'hypertrophie de la prostate** (trouble mictionnel : pollakiurie, impériosité, dysurie, nycturie, latence mictionnel, jet faible, trouble de l'érection, trouble de l'éjaculation)
- **Vessie neurogène** (pollakiurie, fuites, nycturie, dysurie, latence mictionnelle, jet saccadé, sensation de mal vidange, souvent autre plainte neuro)

- **Gonorrhée** (goutte de pus - écoulement, démangeaison, dysurie, fièvre, abdomen aigu, douleur à la mobilisation du col, DD frottis chlamydia – gonorrhée, ttt : ceftriaxone + azithromycine)
- **Chlamydia** (goutte de pus - écoulement, démangeaison, dysurie, fièvre, abdomen aigu, douleur à mobilisation du col, DD frottis chlamydia – gonorrhée, ttt : doxycycline ou macrolide)
- **Mycose** (démangeaison, perte inhabituelle, douleurs lors de la miction, douleur lors des rapports sexuels, ttt : ovule)
- **Trichomonas** (démangeaison, perte vaginale purulente, douleurs lors de la miction, douleur lors des rapports sexuels, cervix érythémateux)
- **Herpès génital** (rouge, tuméfié, bulle → ulcère, ttt : acyclovir)
- **Syphilis** (chancre en aigu – ulcère sur les OGE, adénopathie, DD : prise de sang, ttt : penicilline G)